



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نوار رجب مدبولى سليمان
المحافظة : القليوبية
الحى / المدينة : طوخ
رقم البطاقة : 28506251402147 رقم التليفون : 01120845423
العنوان : مشتهر
العمر (تاريخ الميلاد) : 25-06-1985 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبتات
الاروماتيز [14161]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: نوار رجب مديولى سليمان National ID: 28506251402147	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



1ms
1000 + 1000

Patient Name		نورا رجب مديولي	
Sex	F	Age	41
Family History	-ve	Special habits	
Surgical History		Comorbidity	
Menopausal Status	pre	Telephone	01141913861
ID	28506251402147	Marital Status	
Date	13-10-2025	Medical ID	3049/2023
		Reason for MDT	

Medical Report

Affected breast:

Pathology: IDC

ER: 8/8

PR: 8/8

HER2: 0

Ki67: 20%

T N M:

Premenopausal Rt breast IDC cT2 N1 M0 received NACT (AC/TXT)
Rt MRM (2/2022) ypT2 N2 → PORT → Zoladex / AI

S.M:

Metsworkup:

Doctor's notes:

Recommendations:

To add zometa

MDT DECISION

For: adjuvant et zoladex+femara + zometa every 6 months

Name

د/شيماء لاشين

د/نرمين رمضان

Signature

[Signature]
13/10/2025

[Signature]
Narmen Ramadan



Patient Name : الأستاذة / نورا رجب مذبولى	Request No. : 13000305
Patient No. : 28506251402147	Request Date : 27/02/2024
Path No. : 786/24	Verification Date : 11/03/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 38 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Right modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:

- * Procedure: Right MRM measured 26x25x5.5cm with covering skin ellipse measured 26x13cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 2.5x2x1 cm. **YPT2**
- * Skin involvement: Nipple is slightly retracted.
- * Distance from margins: 1.5cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: 17 L.Ns up to 1.5x1cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 2.5 cm
- Actual tumor cellularity: 70%, tumor necrosis index: 30%
- * Ductal carcinoma in situ: 10%
- * Skin involvement: free nipple
- * Lymph node involvement: metastatic deposits **5/17** with extracapsular extension. **YPTN2**
- * Resection Margins: Free
- * Histologic response to therapy: Pathological partial response
- * Microcalcifications: No

Diagnosis:

Right breast cancer post NACT, MRM specimen:

Invasive duct carcinoma, grade II

Verified by :

Dr.Mohamed Torky





Patient Name : الأستاذة / نورا رجب مديولي	Request No. : 13000305
Patient No. : 28506251402147	Request Date : 27/02/2024
Path No. : 786/24	Verification Date : 11/03/2024
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 38 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Maximal tumor diameter: 2.5 cm
- Actual tumor cellularity: 70%, tumor necrosis index: 30%.
- Resection Margins: Free
- Skin: Free
- Lymph nodes: Metastatic deposits 5/17 with extracapsular extension.
- Histologic response to therapy: Pathological partial response.
- Stage: ypT2, ypN2
- RCB: 3.784, RCB class III.

Signature:

Dr.Rana Fathy

Dr.Muhammad Torkey

Verified by :

Dr.Mohamed Torky

Printing Date : 17/03/2024 10:21:35

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Name: م/نورا رجب متولى سليمان Age: 45 Ys Sex: Female Date: 18 / 7 / 2023
Clinical Diagnosis: Suspicious Rt. Breast Mass Path No.: J71-23
Referred by Prof. Dr.: Ahmed Farid

Pathology Report

Gross Picture: A core of grayish-whitish tissue; 0.6 cm. long, totally submitted.

Microscopic Picture: Revealed breast parenchymal tissue showing evidence of involvement by an infiltrating malignant epithelial growth, disposed in cords, trabeculae, masses & glandular structures, formed of medium-sized moderately-pleomorphic cells, having abundant eosinophilic cytoplasm, irregular hyperchromatic nuclei; with coarse chromatin stippling, apparent nucleoli and moderate mitotic activity. The stroma showed cellular desmoplasia, fibrosis, hyalinization, elastosis and mild lymphocytic infiltrate. No In-Situ carcinoma component or perineural invasion or Indian Files or microcalcific deposits detected.

Diagnosis: U/S-Guided Tru-Cut Biopsy – Suspicious Rt. Breast Mass:

B5; Malignant: Invasive Breast Carcinoma (NST); GII, Involving 80% of the Core.

Please Correlate with Clinical and Sono/ Mammographic Findings.

N.B.: Case N0. (J71-23), 2 slides enclosed.

Signature

أ. ش. هانى كامل – بجوار شرطة النجدة – أمام مدرسة هدى شعراوي
الدور الأول علوى – بنها

محمول: ٠١٢٨١٩٦٦٠٤٢ – ٠١٠٩١٣٩٠٤٣٤ عمل: ٠١٣/٣٢٢٣٨١٨

emaranashwa6@gmail.com

Dr.
Nashwa M. Emara
Prof. of Pathology
Benha Faculty of Medicine



دكتورة
نشوى محمد عمارة
دكتوراه تحاليل الأنسجة والأورام
أستاذ وإستشاري بكلية طب بنها

Name: **Age: 45 Ys Sex: Female**
نورا رجب متولى سليمان

Clinical Diagnosis:

Suspicious Rt. Breast Mass

Date: 6 / 8 / 2023

Referred by Prof. Dr.:

Path No.: K62-23

Abdel-Halim Mahmoud

Pathology Report

Immunostaining Report

Specimen Nature:

- Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue of U/S-Guided Tru-Cut Biopsy; Rt. Breast Mass of an Already Diagnosed Case of B5; Malignant: Invasive Breast Carcinoma (NST); GII, Involving 80% of the Core.

Procedure:

- Thin tissue sections of the previous case were cut on +ve charged slides & prepared for Immunohistochemical study.
- Sections were treated with Abs against Estrogen Receptor (ER), Progesterone Receptor (PR) & Ki67; then stained by sensitive detection kit using peroxidase-conjugate & DAB chromogen.

Results:

ER: Marked Positive Reaction for ER (95% of Cells, Intensity +++) (Score 8/8).

PR: Marked Positive Reaction for PR (95% of Cells, Intensity +++) (Score 8/8).

Ki67: High Ki67 Labeling Index of about 25% in the Hotspots.

N.B.: Case No. (K62-23), 3 slides enclosed.

Signature

أش هانى كامل - بجوار شرطة النجدة - أمام مدرسة هدى شعراوي
الدور الأول علوى - بنها

محمول: ٠١٢٨١٩٦٦٠٤٢ - ٠١٠٩١٣٩٠٤٣٤ عمل: ١٣/٣٢٢٣٨١٨
emaranashwa6@gmail.com

Clinical Diagnosis:

Referred by Prof. Dr.:

Age: 45 Ys Sex: Female
Suspicious Rt. Breast Mass

Abdel-Halim Mahmoud

Pathology Report

Immunostaining Report

Date: 6 / 8 / 2023

Path No.: K62-23

Specimen Nature:

- Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Tissue of U/S-Guided Tru-Cut Biopsy; Rt. Breast Mass of an Already Diagnosed Case of B5; Malignant: Invasive Breast Carcinoma (NST); GII, Involving 80% of the Core.

Procedure:

- Thin tissue sections of the previous case were cut on +ve charged slides & prepared for Immunohistochemical study.
- Sections were treated with an Ab against c-erbB-2 (HER2/neu) then stained by sensitive detection kit using peroxidase-conjugate & DAB chromogen.

Results:

c-erbB-2 (HER2/neu): Negative (Score 0); with No Membranous Staining was observed in any of the Tumor Cells.

P.O.: Only the cell membrane staining intensity and pattern in the invasive part of tumor are evaluated to detect c-erbB-2 (HER2/neu) protein over-expression.

N.B.: Case No. (K62-23), one slide enclosed.

Signature

أ. ش. هاني كامل - بجوار شرطة النجدة - أمام مدرسة هدى شعراوي
الدور الأول علوى - بنها
محمول: ٠١٢٨١٩٦٦٠٤٢ - ٠١٠٩١٣٩٠٤٣٤ عمل: ١٣/٣٢٢٣٨١٨
emaranashwa6@gmail.com



Patient Name: Nora Ragab Madboli Soliman	Date : 14/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 3049/2023	Pat. ID: 46050

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

left breast pathologically proven malignant mass on NACT for assessment.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Right breast shows LOQ spiculated irregular mass lesion, of equal density.
- Complementary ultrasound revealed right breast irregular spiculated hypoechoic mass lesion, seen at 7.00 measuring 2.8 x 1.8cm (was 3 x 2cm, in prior study dated 15/7/2023)
- No right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex of the right breast.
- Nonspecific left axillary LN.
- Right subcentimetric axillary lymph nodes.
- Free left infra and supra-clavicular regions.

Opinion:

- Stationary course of the right breast malignant mass and axillary lymph nodes (BIRADS 6)

Yours truly

Dr.Wafaa Ali



Pat. Name: نورا رجب مديولي سليمان	Pat. ID: 596395
	Date 18/08/2023

POST-CONTRAST MDCT SCAN EXAMINATION OF THE CHEST

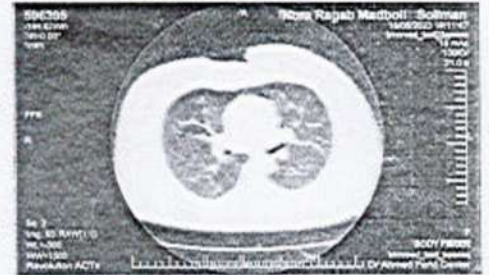
Technique:

- **Acquisition:** Helical, IV contrast.
- **Reconstruction:** millimetric in three planes, bone and soft tissue algorithms & 3D MIP bronchography
- **Low Dose** radiation protocol are used.

Findings:

Known patient of right breast carcinoma

- ⊙ Right breast area of parenchymal distortion with surrounding spiculations
- ⊙ Right axillary few lymph nodes enlargement, the largest measures 15x12 mm
- ⊙ No pulmonary alveolar or interstitial masses or infiltrations seen with normal aeration of both lungs.
- ⊙ No evidence of mediastinal or hilar lymph node enlargement or masses.
- ⊙ Normal cardiac size and shape with no gross abnormality
- ⊙ No evidence of pleural or pericardial sac collections.
- ⊙ Unremarkable upper abdominal cuts.



Opinion :

- Right breast area of parenchymal distortion with right mild axillary lymphadenopathy for sonomammography and histopathological correlation
- Normal Post contrast CT chest examination with no pulmonary or mediastinal metastatic deposits

Dr. Sherif Elrefai (MD)

Dr. Hend Gamal, Msc